

FICHA TÉCNICA MONOGRÁFICA DE EVALUACIÓN CLÍNICA

DTS · ESCALA DE TRAUMA DE DAVIDSON

Davidson Trauma Scale – Autoinforme de 17 síntomas DSM-IV en dimensiones pareadas de frecuencia e intensidad

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial	Davidson Trauma Scale (DTS)
Autores Originales	Jonathan R. T. Davidson, S. W. Book, J. T. Colket, L. A. Tupler et al. (1997)
Adaptación Española	Julio Bobes, Alfredo Calcedo-Ordóñez, M. Paz García-Portilla, M. Bousoño et al. (2000)
Tipo de Instrumento	Autoinforme estructurado bidimensional de estrés postraumático
Población Diana	Sujetos adultos expuestos a eventos potencialmente traumáticos graves (Criterio A)
Tiempo de Aplicación	8 a 12 minutos (17 reactivos dobles: 34 valoraciones)
Formato de Respuesta	Doble escala Likert de 5 puntos: Frecuencia (0-4) y Gravedad/Malestar (0-4)
Finalidad Clínica	Cribado diagnóstico, cuantificación dimensional de la severidad del TEPT y monitorización sensible de la respuesta al tratamiento médico o psicoterapéutico

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO TEÓRICO

La Escala de Trauma de Davidson fue desarrollada en la Duke University para subsanar una deficiencia metodológica común en los cuestionarios de estrés postraumático: la confusión entre la frecuencia temporal de un síntoma (cuántas veces ocurre a la semana) y la gravedad o intensidad intrusiva del malestar que genera en el paciente cuando se manifiesta. La DTS evalúa exactamente los 17 criterios sintomáticos del TEPT según el DSM-IV, solicitando al sujeto que califique cada síntoma de forma independiente en ambas dimensiones respecto a la semana previa.

El modelo teórico mapea con fidelidad la tríada nosológica clásica: a) Síntomas de Intrusión y Reexperimentación (Criterio B: recuerdos angustiosos, pesadillas, flashbacks, reactividad fisiológica al recuerdo); b) Síntomas de Evitación y Embotamiento Afectivo (Criterio C: evitación de pensamientos y lugares, amnesia psicógena, anhedonia, apego disminuido, futuro desolador); y c) Síntomas de Hiperactivación o Hiperarousal (Criterio D: insomnio, irritabilidad/ira, dificultad de concentración, hipervigilancia, sobresalto exagerado).

3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Criterio DSM-IV	Nº Ítems	Ítems Constituyentes	Manifestaciones Sintomáticas Evaluadas
Criterio B: Intrusión	4 ítems	1, 2, 3, 4	Recuerdos dolorosos involuntarios, sueños traumáticos, flashbacks y distrés ante disparadores.
Criterio C: Evitación	7 ítems	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	Esfuerzos de evitación cognitivo-conductual, anestesia emocional, desapego y anhedonia.
Criterio D: Hiperarousal	6 ítems	12, 13, 14, 15, 16, 17	Alteración del sueño, estallidos de cólera, concentración disminuida y sobresalto autonómico.
DTS Total Combinada	17 ítems	Suma Frecuencia + Gravedad	Puntuación global de carga psicopatológica de estrés postraumático (0 a 136 puntos).

Estructura métrica: Cada ítem genera dos puntuaciones (Frecuencia de 0 a 4 y Gravedad de 0 a 4). La suma máxima de Frecuencia es 68, la de Gravedad es 68, y el total absoluto oscila entre 0 y 136 puntos.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMACIÓN Y REGLAS DE CORRECCIÓN · DTS

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATINOAMÉRICA

Consistencia Interna	Alfa de Cronbach excepcional: Global = 0.99 en la validación española de Bobes et al. (2000). Subescalas: B (alfa = 0.97), C (alfa = 0.98), D (alfa = 0.97).
Fiabilidad Test-Retest	Coefficiente de correlación $r = 0.86$ a 0.89 en un intervalo de 1 a 2 semanas en pacientes estables.
Validez Diagnóstica (ROC)	Con punto de corte total de 40 puntos: Sensibilidad = 88%, Especificidad = 86%, Eficiencia diagnóstica global = 87% frente a entrevista clínica SCID-I.
Validez Convergente	Correlación sobresaliente con la CAPS-1 ($r = 0.89$), IES-R ($r = 0.84$), STAI-Rasgo ($r = 0.72$) y escala de depresión de Montgomery-Asberg (MADRS, $r = 0.68$).

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁMPUTO DE PUNTUACIONES

- Calificación de Frecuencia (Columna Izquierda):** 0 = Nunca; 1 = A veces (1 vez/semana); 2 = A menudo (2-3 veces/semana); 3 = Muy a menudo (4-6 veces/semana); 4 = A diario / casi todos los días.
- Calificación de Gravedad (Columna Derecha):** 0 = Nada de molestia; 1 = Leve; 2 = Moderada; 3 = Grave; 4 = Extrema / totalmente incapacitante.
- Cálculo de Subtotales:**
 - Subtotal Frecuencia:* Suma de frecuencias de los 17 ítems (Rango: 0 a 68).
 - Subtotal Gravedad:* Suma de gravedad de los 17 ítems (Rango: 0 a 68).
- Puntuación Global Compuesta:** Suma de ambos subtotales (Rango: 0 a 136 puntos).

6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

Puntuación DTS	Estratificación	Probabilidad TEPT	Significado Clínico y Manejo
0 a 39 puntos	Ausencia / Leve	Baja (< 10%)	Síntomas traumáticos subsindrómicos o adaptativos normales.
40 a 59 puntos	TEPT Clínico Moderado	Alta (Corte Oficial 88%)	Confirmación diagnóstica indicada; psicoterapia focalizada.
60 a 89 puntos	TEPT Moderado-Severo	Muy Alta (> 92%)	Severo menoscabo psicosocial; tratamiento multimodal.
90 a 136 puntos	TEPT Extremo / Incapacitante	Extrema (> 98%)	Cuadro altamente invalidante con riesgo autolítico elevado.

PUNTO DE CORTE OFICIAL EN ESPAÑA (DTS TOTAL ≥ 40): El estudio de validación de Bobes et al. (2000) en población española demostró que un punto de corte total de 40 puntos maximiza la sensibilidad (88%) y la especificidad (86%) para el diagnóstico de TEPT. Para ensayos clínicos de eficacia farmacológica se utiliza habitualmente un umbral de inclusión más estricto de ≥ 50 puntos.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y DIRECTRICES · DTS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA E INTERVENCIÓN

Paso 1: Identificación del Evento Índice: Confirmar que el paciente ha sufrido o presenciado un evento traumático (Criterio A).

Paso 2: Valoración de Puntuaciones Parciales y Totales:

- **Si DTS Total < 40:** No cumple criterio umbral de TEPT sindrómico. Reevaluar en 4 semanas si el trauma fue reciente (< 3 meses) para vigilar posible inicio demorado.
- **Si DTS Total ≥ 40:** Diagnóstico presuntivo de TEPT positivo.
 1. Evaluar si predomina la subescala de intrusión (Criterio B) para priorizar reprocesamiento cognitivo o EMDR.
 2. Evaluar hiperarousal severo (Criterio D > 20): valorar indicación de ISRS (sertralina, paroxetina) o prazosina si coexisten pesadillas severas refractarias.
- **Monitorización del Tratamiento:** Se define "Respuesta Terapéutica Significativa" ante una reducción ≥ 30% en la puntuación total de la DTS respecto al valor basal.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO (VIGNETTE)

Identificación: Varón de 39 años, conductor de transporte público, acude a consulta especializada tras sufrir un asalto violento a mano armada en su vehículo hace 4 meses. Refiere insomnio de conciliación, sudores fríos, taquicardia al conducir e irritabilidad extrema con su cónyuge.

Evaluación Psicométrica Inicial: DTS Total = 74 / 136 puntos (Frecuencia = 38, Gravedad = 36; TEPT Moderado-Severo).

- **Intrusión (B):** 21 / 32 puntos. Flashbacks diarios al detenerse en semáforos y pesadillas recurrentes del asalto.
- **Evitación (C):** 27 / 56 puntos. Incapacidad de volver a la ruta del suceso y distanciamiento emocional de su familia.
- **Hiperarousal (D):** 26 / 48 puntos. Estado constante de alerta motora y reacción de sobresalto desmedida ante ruidos.

Plan de Intervención: Se inició psicoterapia cognitivo-conductual centrada en trauma (TCC-CT) con exposición prolongada imaginaria y en vivo, asociada a paroxetina 20 mg/día. Tras 14 sesiones, la puntuación en la DTS descendió a 22 puntos (reducción del 70.2%), situándose por debajo del umbral clínico (40 puntos), con reincorporación exitosa al puesto laboral y remisión completa de los flashbacks.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTAS CRÍTICAS DE SEGURIDAD

- Puntuaciones extremas en la subescala de Evitación/Embotamiento (C) suelen correlacionar con ideación suicida pasiva y desesperanza grave.
- Descartar descompensación psicótica en pacientes con flashbacks extremadamente vívidos con pérdida del juicio de realidad.

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

- **Trastorno de Estrés Agudo:** Duración de los síntomas entre 3 días y 1 mes post-evento.
- **Trastorno de Adaptación:** El estresor vital no reúne la gravedad amenazante para la vida del Criterio A clásico del TEPT.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

- Davidson, J. R., Book, S. W., Colket, J. T., Tupler, L. A., Roth, S., David, D., ... & Feldman, M. E. (1997). Assessment of a new self-rating scale for post-traumatic stress disorder. *Psychological Medicine*, 27(1), 153–160.
- Bobes, J., Calcedo-Ordóñez, A., García-Portilla, M. P., Bousoño, M., Gómez, J. M., Cabrera, J., ... & Grupo de Trabajo de la DTS en España. (2000). Evaluación de las propiedades psicométricas de la versión española de la Escala de Trauma de Davidson (DTS). *Actas Españolas de Psiquiatría*, 28(4), 207–218.
- Davidson, J. R., Tharwani, H. M., & Connor, K. M. (2002). Davidson Trauma Scale (DTS): Normative reserve and clinical application. *Journal of Clinical Psychiatry*, 63(Suppl 5), 23–28.
- American Psychiatric Association. (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders* (4th ed., text rev.). APA.